Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Esta pauta –de uso optativo- ha sido diseñada para facilitar a los profesionales que realizan los procesos de evaluación de NEE, en el marco del Decreto 170, la recogida de antecedentes de anamnesis relevantes del estudiante. Puede ser completada por uno o más profesionales en el proceso de detección y evaluación de las NEE que presenta el alumno(a) y de los apoyos que requiere para aprender y participar en el contexto escolar.

1. DENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre	Facundo Thiago Rehaño Charéz				Sexo	F	M X
Fecha Nacimiento	27/09/2012	Edad actual	11 años	5 meses	País natal:	Perú	
Domicilio actual:	Lautaro 686 V. Las Américas				Teléfono	975877943	
Lengua materna	Español	Grado dominio	comprende ☑ habla ☑ lee ☑ escribe ☑				
Lengua de uso	Español	Grado dominio	comprende ☑ habla ☑ lee ☑ escribe ☑				
Escolaridad actual:	8° básico	Establecimiento	Liceo Mixto Básica 2				

2. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS INFORMANTES

1. Fecha de la entrevista: 18/03/2026	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Adela Chárez A.	Nombre:
Relación con el/la estudiante: Madre	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):
3. Fecha de la entrevista:	4. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Relación con el/la estudiante:	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):

3. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS ENTREVISTADORES

1. Fecha de la entrevista: 18/03/2026	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Itania Barraco	Nombre:
Rol/cargo: Ed. diferencial	Rol/cargo:
3. Fecha de la entrevista:	3. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Rol/cargo:	Rol/cargo:

4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN QUE MOTIVA LA ENTREVISTA

Continuidad Programa Integración Escolar.

5. ANTECEDENTES RELATIVOS AL DESARROLLO Y A LA SALUD DEL/LA ESTUDIANTE

¿El o la estudiante tiene algún diagnóstico previo? ☐ No ☑ Sí **(especificar)**

Pediatría:	Psicología:
Kinesiología:	Psiquiatría:
Genético:	Psicopedagogía: DEA 2024
Fonoaudiología:	Terapia Ocupacional:
Neurología:	Otro:

5.1. Primer año de vida

Tipo de parto: ☑ normal ☐ inducido ☐ fórceps ☐ cesárea (señalar motivo)

Tuvo asistencia médica durante el parto? ☑ SI ☐ NO	Peso: 3.500 kg	Talla: 50 cm

Señale antecedentes relevantes del Embarazo y Parto:

al nacer le dio ictericia (ojos y piel amarilla)
Lactancia hasta el año de vida.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Señale si durante los doce primeros meses de vida el niño o niña presentó:								
Desnutrición	Si	~~No~~	Traumatismos	Si	~~No~~	Encefalitis	Si	~~No~~
Obesidad	Si	~~No~~	Intoxicación	Si	~~No~~	Meningitis	Si	~~No~~
Fiebre alta	~~Si~~	No	Enfermedad respiratoria	~~Si~~	No	Otra(s)		
Convulsiones	Si	~~No~~	Asma	~~Si~~	No			
Hospitalizaciones	Si	~~No~~	Especifique motivos y duración: Presento asma durante 6 meses					
Se realizaron controles periódicos de salud		~~Si~~	No			Vacunas	~~Si~~	No

Observaciones:

actualmente tiene alta médica de asma

5.2. Desarrollo Sensorio Motriz

Edad en que el niño (a)

Fija la cabeza: 5 m	Se sienta sólo/a: 7 m	Camina sin apoyo: 14, 2 meses
Primeras palabras: 8 m	Primeras frases: 12 m	Se viste solo/a: 5 años
Controla esfínter vesical Diurno: Si Nocturno: Si		Controla esfínter anal Diurno: Si Nocturno: Si

Observaciones:

sin antecedentes relevantes

En su actividad motora general se aprecia:	**Su tono muscular general se aprecia:**
☑ normal ☐ activo ☐ hiperactivo ☐ hipoactivo	☑ normal ☐ hipertónico ☐ hipotónico

En relación con su motricidad gruesa se aprecia:								
Estabilidad al caminar	~~Si~~	No	Caídas frecuentes	Si	~~No~~	Dominancia lateral	~~Si~~	No
En relación con su motricidad fina el niño (a) logra:								
Garra	~~Si~~	No	Prensión	~~Si~~	No	Pinza	~~Si~~	No
Ensarta	~~Si~~	No	Dibuja	~~Si~~	No	Escribe	~~Si~~	No

En relación con algunos signos cognitivos el niño (a)					
Reacciona a voces o caras familiares	~~Si~~	No	Manipula y Explora objetos	~~Si~~	No
Demanda objetos y compañía	~~Si~~	No	Comprende prohibiciones	Si	No
Sonríe, balbucea, grita, llora, indica o señala	~~Si~~	No	Posee evidente descoordinación ojo-mano	Si	~~No~~

Observaciones: Comenzó su actividad motora con dominancia mano zurda, luego la madre se ausenta por dos años y cuando vuelve escribia con mano derecha.

5.3. Visión - Audición:

Se interesa por los estímulos visuales (colores, formas, movimientos, etc.)	~~Si~~	No	Se interesa por los estímulos auditivos (ruidos, voces, música, etc.)	~~Si~~	No
En ocasiones tiene los ojos irritados o llorosos	~~Si~~	No	Reacciona o reconoce voces o sonidos familiares	~~Si~~	No
Presenta dolores frecuentes de cabeza	Si	~~No~~	Gira la cabeza cuando se le llama o ante un ruido fuerte	~~Si~~	No
Se acerca o aleja demasiado los objetos a la vista (frunce el ceño)	~~Si~~	No	Acerca los oídos a la TV, radio o fuente de sonido.	Si	~~No~~
Sigue con la vista el desplazamiento de los objetos o personas	~~Si~~	No	En ocasiones se tapa o golpea los oídos	Si	~~No~~
Presenta movimientos oculares "anormales"	Si	~~No~~	Presenta frecuentes dolores de oídos	Si	~~No~~
Manifiesta conductas "erróneas" (tropiezos, choques)	Si	~~No~~	La pronunciación oral es adecuada	~~Si~~	No
Presenta diagnóstico médico de miopía, estrabismo, astigmatismo, u otro.	Si	~~No~~	Presenta diagnóstico médico de otitis crónica, hipoacusia u otra.	Si	~~No~~

Observaciones: se solicitara evaluacion por Junaeb a oftalmólogo

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

5.4. Desarrollo de
El niño (a) se cor

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.4. Desarrollo del Lenguaje					
El niño (a) se comunica preferentemente en forma ☐ oral ☐ gestual ☑ mixto ☐ otro (especifique):					
Características del lenguaje expresivo					
Balbucea (oral o señas)/emite sonidos	Sí	No	Emite/produce frases	Sí	No
Vocaliza/realiza gestos o señas aisladas	Sí	No	Relata experiencias	Sí	No
Emite palabras/produce señas	Sí	No	La emisión/pronunciación/producción es clara	Sí	No
Características del lenguaje comprensivo					
Identifica objetos	Sí	No	Sigue instrucciones simples	Sí	No
Identifica personas	Sí	No	Sigue instrucciones complejas	Sí	No
Comprende conceptos abstractos	Sí	No	Sigue instrucciones grupales	Sí	No
Responde en forma coherente preguntas de la vida diaria	Sí	No	Comprende relatos, noticias, cuentos cortos	Sí	No
Manifestó pérdida del lenguaje oral (especifique edad y motivos): NO					
Observaciones: Sin observaciones relerantes					

5.5. Desarrollo Social					
Se relaciona espontáneamente con las personas de su entorno natural.	Sí	No	Se relaciona en forma colaborativa	Sí	No
Explica razones de sus comportamientos y actitudes	Sí	No	Respeta normas sociales	Sí	No
Participa en actividades grupales	Sí	No	Respeta normas escolares	Sí	No
Opta por trabajo individual	Sí	No	Muestra sentido del humor	Sí	No
Presenta lenguaje ecolálico	Sí	No	Movimientos estereotipados	Sí	No
Exhibe dificultad para adaptarse a situaciones nuevas	Sí	No	Pataletas frecuentes	Sí	No
Ante los siguientes estímulos su reacción es:					
Luces: ☑ natural ☐ desmesurada			**Sonidos:** ☑ natural ☐ desmesurada		**Personas extrañas:** ☑ natural ☐ desmesurada
Observaciones: Sin antecedentes relevantes					

5.6. Estado Actual de Salud del/la Estudiante					
Vacunas al día	Sí	No	Trastorno motor	Sí	No
Epilepsia	Sí	No	Problema bronco-respiratorio	Sí	No
Problemas cardiacos	Sí	No	Enfermedad infecto-contagiosa	Sí	No
Paraplejia	Sí	No	Trastorno emocional	Sí	No
Pérdida auditiva	Sí	No	Trastorno conductual	Sí	No
Pérdida visual	Sí	No	Otro (especifique):		
El o los problemas de salud reciben control/tratamiento (especifique): Sin antecedentes de salud importantes.					
Alimentación: ☐ normal ☐ "malo/a" para comer ☑ "bueno/a" para comer ☐ Otro (especifique)					
Peso (apreciación del informante): ☑ normal ☐ bajo peso ☐ obesidad					
Sueño: ☑ normal ☐ tranquilo ☐ inquieto Horas que duerme: 8					
☐ insomnio ☐ pesadillas ☐ terrores nocturnos ☐ sonambulismo ☐ despierta de buen humor			Duerme: ☐ solo ☐ acompañado (Especifique):		
Humor/comportamiento *(señale el comportamiento habitual)*					
☐ alegre ☐ juguetón/bromista ☐ risueño(a) ☑ triste ☑ serio ☐ rebelde ☑ apático ☐ violento(a) Otro:					
Observaciones: Estudiante muy introvertido.					

6. ANTECEDENTES FAMILIARES

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

☐ Ambos ☐ Sólo físic

Comentarios u otras

Personas que viven con el niño o niña y/o que son que son responsables de su cuidado.				
Nombre	Parentesco	Edad	Escolaridad	Ocupación actual
1. Adela Chávez	madre	45	tec. sup.	Asesora. hogar
2. José María Rehaño	hermano	20	tec. sup.	Estudiante
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Antecedentes de Salud de la Familia

(Señale aquellos antecedentes que son relevantes en función de la entrega de apoyos que requiere el o la estudiante):

Estuvo en tratamiento psicológico en 2025, decía tener un amigo imaginario. Actualmente madre no lo ha podido llevar a más sesiones.

Observaciones:

Papá vive en Perú no lo ve hace 2 años. Este fue papá con su nueva pareja, sin embargo, Facundo tomó bien la noticia, pese a los miedos de la mamá

7. ANTECEDENTES ESCOLARES Y APOYO DE LA FAMILIA

Trayectoria escolar

Edad de ingreso al sistema escolar	6	Asistió a jardín infantil	Sí / ~~No~~
Nº de colegios en que ha estudiado	2	Modalidad de enseñanza Regular ☐ Especial ☐ Técnica ☐:	
Motivo de los cambios: Mudanza			

Ha repetido curso/s	Sí	No	Curso(s)	Motivo:

Situación actual

Nivel/curso actual	8vo		**Dificultad de aprendizaje**	Sí	No	**Dificultad para participar**	Sí	No	**Conducta disruptiva**	Sí / **No**
Asiste regularmente	Sí	No	Asiste con agrado	Sí	No	Apoyo familiar en tareas	Sí	No	Amigos (as) Pocos	Sí / No

Actitud de la familia

¿Cómo evalúa la familia el desempeño escolar del estudiante?

☑ satisfactorio ☐ insatisfactorio (motivos) .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a las dificultades escolares del estudiante?

☑ apoyo ☐ castigo ☐ indiferencia ☐compasión ☐ tensión ☐ otra .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a los éxitos escolares del estudiante?

☑ apoyo ☐ indiferencia ☐ otra .....

Especifique el tipo de refuerzos o premios:

☑ expresiones afectivas ☐ alimentos preferidos ☐ ver TV ☐ juguetes ☐ tiempo libre ☐ otro(s).....

¿Quiénes apoyan el proceso de aprendizaje y desarrollo del estudiante?

☑ madre ☐ padre ☐ hermanos/as ☐ Otros familiares ☐ Otros profesionales .....

¿Qué expectativas muestra la familia frente al futuro escolar del estudiante?

☑ alta (incluye al grupo familiar) ☐ mediana (incluye sólo madre/padre) ☐ baja (no incluye a ningún miembro)

¿Ofrece la familia un ambiente físico y emocional adecuado para el aprendizaje? Sí

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

☐ Ambos ☐ Sólo físico (espacios, materiales, ventilación, luminosidad) ☐ Sólo emocional (tranquilo, relajado, comprensivo)

Comentarios u otras observaciones relevantes que no se han registrado o explorado:

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY